



GUIA PARA PACIENTES

Fisgada atrás da coxa

o que fazer nas primeiras 72 horas e quando voltar pro jogo

Como reconhecer a lesão dos músculos de trás da coxa, cuidar dela nos primeiros dias e voltar à pelada por critérios, e não pela data no calendário.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **COXA**

Para quem é:

Para adultos que jogam bola e sentiram uma **fisgada atrás da coxa** numa arrancada, num chute ou numa freada, e **não têm nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Crianças e adolescentes em fase de crescimento: a dor perto do quadril pode ser lesão do osso em crescimento e deve ser vista por um médico.
- Quem usa remédio para "afinar o sangue": converse com seu médico antes, porque o roxo pode ser maior.
- Quem já teve **duas ou mais lesões** no mesmo lugar: leia a Página 9 e procure avaliação.

O que tu vais precisar:

- Uma bolsa de gelo ou gelo envolto num pano.
- Um colchonete ou tapete, para os exercícios deitado.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Se mexer e caminhar **dentro do que a dor permite**: sim.

Alongar forte, massagear com força ou "testar" com arrancada: **não**, nos primeiros dias.

Algum sinal da Página 3: **pare e procure atendimento**.

A maioria das fisgadas é uma lesão do músculo que melhora com cuidado e exercício. Mas alguns sinais indicam lesão maior. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure avaliação com ortopedista logo (de preferência na mesma semana) se:

- Tu ouviste ou sentiste um **estalo** na hora da lesão.
- Apareceu um **roxo grande** (hematoma) atrás da coxa, que desce em direção ao joelho.
- Tu **não consegues andar** ou **não consegues apoiar** a perna sem mancar muito.
- A **dor é forte**, já no momento da lesão e no primeiro exame.
- A dor é **bem no alto**, perto do osso em que a gente senta, e piora ao sentar.
- Tu sentes um **"buraco"** ou um caroço diferente atrás da coxa.

Estalo, roxo e dor forte no início estão entre os sinais ligados a uma recuperação **mais demorada** [3]. Quando o tendão se solta do osso lá no alto, perto do bumbum, a cirurgia teve resultados melhores que o tratamento sem cirurgia nos estudos reunidos [3]. Por isso esse caso **não deve esperar** (opinião clínica: o tempo até a avaliação importa).

Procure o pronto-socorro HOJE se:

- A perna está **muito inchada e tensa**, com dor que só aumenta.
- Há **dormência**, formigamento que não passa ou o pé ficou **frio ou arroxeadado**.

Os músculos de trás da coxa

Atrás da coxa ficam três músculos, chamados **isquiotibiais**. Eles vão do osso em que a gente senta até logo abaixo do joelho. Trabalham forte para **frear a perna** no fim da passada, na arrancada e no chute.

A "fisgada"

Quando a força passa do que o músculo aguenta, parte das fibras **estira ou rompe**. A pessoa sente a fisgada, às vezes para na hora, e depois tem dor para esticar o joelho ou correr.

É comum no futebol

Num estudo que acompanhou por 7 temporadas 23 times profissionais da Europa, a **lesão muscular da coxa** foi o tipo de lesão mais comum: **17% de todas as lesões**. A **lesão de repetição** foi 12% do total e afastou o jogador por mais tempo [1]. O estudo é com profissionais; no futebol amador, os números podem ser diferentes (opinião clínica).

Por que a volta precisa de critério

A lesão que volta costuma ser **pior** que a primeira [1]. Voltar cedo demais é o principal erro (Página 10). A boa notícia: a maioria das lesões do músculo é tratada **sem cirurgia**, com exercício bem conduzido [3].

Proteção relativa

Nos primeiros 1 a 3 dias, **diminua o que provoca dor forte**: nada de correr, arrancar, chutar ou alongar com força. Proteger **não é ficar de cama**. Caminhar em casa e no trabalho, dentro do que a dor permite, faz parte (opinião clínica, alinhada ao PEACE & LOVE [7]).

Sem alongar forte

Alongar com força nos primeiros dias pode puxar justo as fibras que estão cicatrizando (opinião clínica). Mexer o joelho e o quadril de leve, sem dor forte, pode.

Gelo para a dor

O gelo **não acelera a cicatrização** de forma comprovada. Se ele alivia a tua dor, use de 15 a 20 minutos, com um pano entre o gelo e a pele (opinião clínica). Uma proposta muito usada para lesões de partes moles, o PEACE & LOVE, sugere até evitar o gelo [7]: é um editorial, e não um estudo.

Compressão e elevação

Uma faixa elástica firme, sem apertar, e a perna elevada quando estiver sentado ou deitado podem ajudar no inchaço [7]. Dedos frios, roxos ou dormentes: afrouxe.

Quando usar muleta

Use muletas se não consegues andar sem mancar muito ou sem dor forte. Assim que conseguires andar normalmente, deixe a muleta (opinião clínica). Se nem com muleta consegues apoiar, isso é sinal de alerta (Página 3).

E os remédios?

Este guia não indica remédio nem dose. Quem decide é o teu médico.

A dor é o guia

Numa revisão de 9 estudos com 601 lesões, **todos** usaram a dor do próprio paciente para decidir quando avançar a reabilitação [5]. Na prática: avance quando o exercício anterior estiver **sem dor ou com dor leve**.

Exercícios que trabalham o músculo "alongando"

Num estudo com 56 velocistas e saltadores de elite, quem fez exercícios que trabalham o músculo de trás da coxa **em alongamento com controle** voltou a treinar em **49 dias em média**, contra **86 dias** com exercícios convencionais [4]. O estudo é com atletas de elite: os prazos de quem joga pelada podem ser outros.

Lesão perto do tendão demora mais

Nesse mesmo estudo, quando a lesão atingia o tendão lá no alto, a volta demorou bem mais: 73 contra 31 dias, no grupo que se recuperou mais rápido [4]. É mais um motivo para fazer a avaliação quando há sinais da

Página 3.

O que isso quer dizer pra ti

Não existe "15 dias e pronto". O tempo depende do tamanho e do local da lesão. O caminho é **progredir por etapas**, como na Página 7 e na Página 8, e só voltar ao jogo quando passar nos critérios.

A recuperação é diferente para cada pessoa. Nenhum prazo é garantido.

A escolha destes três é opinião clínica. Seguem a lógica de progredir com a dor como guia [5] e de trabalhar o músculo em alongamento com controle [4]. Não substituem o fisioterapeuta.

Regra da dor (orientação prática): dor até 3, numa escala de 0 a 10, que volta ao normal até a manhã seguinte, é aceitável.

Exercício 1 — Ponte segurando (a partir do dia 2 ou 3)

Como fazer: deitado de barriga para cima, joelhos dobrados, calcanhares no chão. Empurre os calcanhares para baixo e suba o quadril até ficar em linha. Segure 10 a 20 segundos, 5 vezes.

Sensação correta: esforço atrás da coxa e no bumbum, sem fisgada.

Erro comum: arquear a lombar para subir mais alto.

Exercício 2 — Aviãozinho (quando o 1 estiver sem dor)

Como fazer: em pé, segurando numa cadeira, incline o tronco para a frente e leve a perna machucada para trás, devagar, com o joelho levemente dobrado. Volte devagar. 2 a 3 séries de 8.

Sensação correta: a coxa de trás "esticando" com controle.

Erro comum: ir fundo e rápido demais, até a fisgada.

Exercício 3 — Do andar rápido ao trote

Como fazer: caminhada rápida por 10 minutos. Sem dor? Alterne 1 minuto de trote leve com 1 minuto de caminhada. Aumente o trote aos poucos, em dias diferentes.

Sensação correta: passada solta, sem mancar.

Erro comum: passar do trote para a arrancada no mesmo dia.

Avance para a etapa seguinte só quando cumprir a anterior (orientação prática, baseada em [5]):

1. **Anda normal, sem mancar e sem dor.**
2. **Exercícios 1 e 2 sem dor**, inclusive com uma perna só.
3. **Corrida leve sem dor** por 15 a 20 minutos.
4. **Força comparável** à da outra perna: a ponte com uma perna só e o aviãozinho saem iguais dos dois lados.
5. **Sprint progressivo**: tiros de 20 a 30 metros a metade, depois a três quartos e por fim quase na velocidade máxima, sem dor, em dias diferentes.
6. **Treino com bola**, com arrancada e mudança de direção, sem dor e **sem medo** de "puxar".
7. **Só então o jogo.**

A força pode ser medida com aparelhos no consultório ou na fisioterapia. Um estudo mostrou que a diferença entre as pernas varia muito, e que **um único número de corte não basta** para liberar o jogador [6]. Por isso a decisão junta força, corrida, sprint e a confiança da pessoa (opinião clínica).

Rastreador

	Dor andando (0–10)	Dor nos exercícios (0–10)	Corrida leve sem dor? (S/N)	Sprint a ¾ sem dor? (S/N)	Confiança (0–10)
Dia 3					
Dia 7					
Dia 10					
Dia 14					
Dia 21					
Dia 28					

Leve esta tabela para a consulta.

O exercício "Nordic hamstring"

Como é: ajoelhado num colchonete, com alguém segurando os teus tornozelos. Com o corpo reto do joelho à cabeça, deixe o tronco cair para a frente **o mais devagar que conseguir**. Apare com as mãos e volte.

Numa revisão com **8.459 atletas** de vários esportes, os programas que incluíam o Nordic **reduziram as lesões de trás da coxa em até 51%**, praticamente a metade [2].

Cuidados (orientação prática): comece com poucas repetições, 1 a 2 vezes por semana, e aumente aos poucos. Dor muscular nos dias seguintes é comum no início. **Não use o Nordic logo depois de uma lesão:** ele entra na prevenção, depois de liberado.

O aquecimento FIFA 11+

É um aquecimento de cerca de **20 minutos**, em três partes: corrida leve com movimentos, depois força, equilíbrio e saltos, e no fim corrida com mudança de direção. **Inclui o Nordic** [8].

- Numa revisão de estudos com jogadores amadores e de nível abaixo da elite, o FIFA 11+ **reduziu as lesões no futebol em 39%** [9].
- Num estudo com 1.892 jogadoras de 13 a 17 anos, o aquecimento reduziu as lesões graves e as lesões por sobrecarga [8].

Prevenção reduz o risco, mas não o zera.

1. Achar que é "só uma fisgada" com estalo e roxo grande.

Esses sinais pedem avaliação logo (Página 3) [3].

2. Alongar forte para "soltar".

Nos primeiros dias, alongamento forçado pode atrapalhar a cicatrização (opinião clínica).

3. Ficar parado demais.

Andar e começar exercícios leves, com a dor como guia, faz parte da recuperação [5][7].

4. Voltar pela data, e não pelos critérios.

Lesão de repetição é comum e afasta por mais tempo [1]. Siga as etapas da Página 8.

5. Pular o sprint progressivo e testar no jogo.

A arrancada é o momento que mais exige o músculo. Teste antes, no treino, em etapas (opinião clínica).

Bônus: não fazer prevenção depois de curar.

O Nordic e o FIFA 11+ reduzem lesões [2][9]. Leva poucos minutos antes da pelada.

Procure avaliação se:

- Tu tens algum sinal da **Página 3**: estalo, roxo grande, não consegues andar ou apoiar, dor forte, dor bem no alto.
- **Não há melhora clara em cerca de 2 semanas** de cuidado bem feito.
- Tu **não passas** de uma etapa da Página 8 depois de várias tentativas.
- É a **segunda ou terceira lesão** no mesmo lugar.
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal de alerta.

O prazo de 2 semanas é bom senso clínico, não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: como foi a lesão, onde dói, a força e a flexibilidade. A ressonância ajuda em alguns casos, mas nenhum achado dela, sozinho, prevê com segurança quem vai ter nova lesão [10]. Exame é pedido quando vai mudar a conduta.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Ekstrand J, Häggglund M, Waldén M. **Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study.** Br J Sports Med. 2011;45(7):553-558. doi:10.1136/bjsm.2009.060582. PMID: 19553225.
2. van Dyk N, Behan FP, Whiteley R. **Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention programmes halves the rate of hamstring injuries: a systematic review and meta-analysis of 8459 athletes.** Br J Sports Med. 2019;53(21):1362-1370. doi:10.1136/bjsports-2018-100045. PMID: 30808663.
3. Rudisill SS, Kucharik MP, Varady NH, Martin SD. **Evidence-based management and factors associated with return to play after acute hamstring injury in athletes: a systematic review.** Orthop J Sports Med. 2021;9(11):23259671211053833. doi:10.1177/23259671211053833. PMID: 34888392.
4. Askling CM, Tengvar M, Tarassova O, Thorstensson A. **Acute hamstring injuries in Swedish elite sprinters and jumpers: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols.** Br J Sports Med. 2014;48(7):532-539. doi:10.1136/bjsports-2013-093214. PMID: 24620041.
5. Hickey JT, Timmins RG, Maniar N, Williams MD, et al. **Criteria for progressing rehabilitation and determining return-to-play clearance following hamstring strain injury: a systematic review.** Sports Med. 2017;47(7):1375-1387. doi:10.1007/s40279-016-0667-x. PMID: 28035586.
6. van Dyk N, Wangenstein A, Vermeulen R, Whiteley R, et al. **Similar isokinetic strength preinjury and at return to sport after hamstring injury.** Med Sci Sports Exerc. 2019;51(6):1091-1098. doi:10.1249/MSS.0000000000001900. PMID: 30640285.
7. Dubois B, Esculier JF. **Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE.** Br J Sports Med. 2020;54(2):72-73. doi:10.1136/bjsports-2019-101253. PMID: 31377722.
8. Soligard T, Myklebust G, Steffen K, Holme I, et al. **Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial.** BMJ. 2008;337:a2469. doi:10.1136/bmj.a2469. PMID: 19066253.
9. Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, Clausen MB, et al. **Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes.** Br J Sports Med. 2017;51(7):562-571. doi:10.1136/bjsports-2016-097066. PMID: 28087568.
10. van Heumen M, Tol JL, de Vos RJ, Moen MH, et al. **The prognostic value of MRI in determining reinjury risk following acute hamstring injury: a systematic review.** Br J Sports Med. 2017;51(18):1355-1363. doi:10.1136/bjsports-2016-096790. PMID: 28259847.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765